OdonTeck
CONSULTING GROUP

ATLAS CLÍNICO · CARIOLOGÍA

Atlas de caries Clasificación ICDAS

Los códigos 0 a 6 explicados uno por uno: cómo se ven, qué tan profundo llegan, cómo saber si están activos y qué hacer con cada uno.

Equipo académico OdonTeck

Edición 1 · septiembre 2026

Por qué ICDAS

El Sistema Internacional de Detección y Valoración de Caries (ICDAS) permite registrar la caries desde su primera manifestación visible en esmalte hasta la cavidad extensa, con criterios reproducibles entre examinadores. Su valor clínico está en detectar lesiones cuando todavía se pueden detener sin taladrar.

Cómo se escribe el código

Cada superficie recibe dos dígitos: el **primero** describe si hay restauración o sellante y el **segundo** el estado de caries. Ejemplo: `02` = superficie sin restaurar con cambio visual evidente en esmalte; `34` = restauración del color del diente con sombra oscura subyacente.

Primer dígito	Restauración o sellante
0	Sin restaurar ni sellar
1	Sellante parcial
2	Sellante completo
3	Restauración del color del diente
4	Amalgama
5	Corona de acero
6	Corona o carilla de porcelana, oro o metal-porcelana
7	Restauración perdida o fracturada
8	Restauración temporal

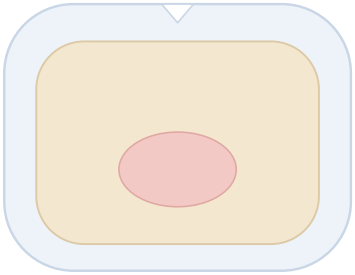
Códigos especiales	Significado
96	Superficie que no puede examinarse
97	Diente ausente por caries
98	Diente ausente por otra razón
99	Diente no erupcionado

Protocolo de examen

1. Retira la placa (profilaxis o cepillado) para ver la superficie real.
2. Aísla con rollos de algodón y ten buena iluminación.
3. Examina cada superficie **húmeda** y después **seca con aire durante unos 5 segundos**.
4. Usa sonda de punta roma (tipo bola) solo para deslizar sobre la superficie y confirmar microcavidades; **no** uses explorador agudo con presión: puede cavitar una lesión remineralizable.
5. Registra también la **actividad** de la lesión: define el tratamiento tanto como el código.

Los siete códigos de caries coronal

Los esquemas representan un corte de molar: esmalte (azul claro), dentina (crema), pulpa (rosa) y la profundidad aproximada de la lesión. Los recuadros punteados están reservados para las fotografías clínicas de OdonTeck.



CÓDIGO 0

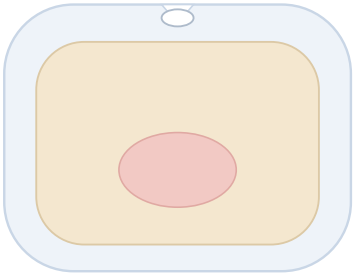
Superficie sana

Sin cambios visibles en el esmalte tras secar con aire durante 5 s. Se aceptan defectos de desarrollo (hipoplasia, fluorosis), desgaste, abrasión y pigmentación extrínseca.

Profundidad aproximada: Sano

Manejo sugerido: Prevención según riesgo: higiene, flúor tópico y control de dieta.

Espacio reservado para fotografía clínica



CÓDIGO 1

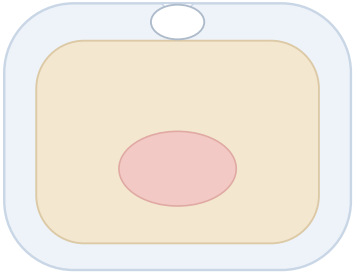
Primer cambio visual en esmalte

Opacidad blanca o marrón visible **solo después de secar**; en húmedo no se aprecia. En fosas y fisuras queda confinada a la fisura.

Profundidad aproximada: Esmalte externo

Manejo sugerido: No operatorio: barniz de flúor, sellante en fosas y fisuras activas, instrucción de higiene y control.

Espacio reservado para fotografía clínica



CÓDIGO 2

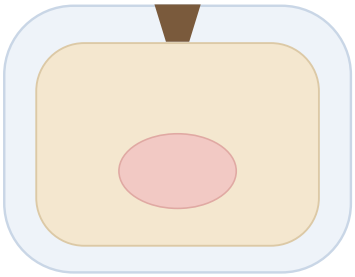
Cambio visual evidente en esmalte

Opacidad blanca o marrón visible **incluso con la superficie húmeda**, más extensa que la fisura.

Profundidad aproximada: Esmalte interno

Manejo sugerido: No operatorio: sellante o infiltración de resina en lisas proximales, flúor de alta concentración, seguimiento.

Espacio reservado para fotografía clínica



CÓDIGO 3

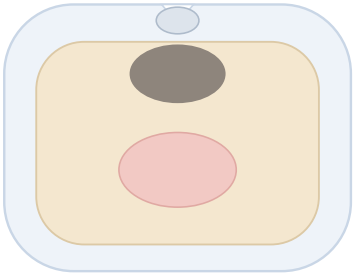
Ruptura localizada del esmalte

Microcavidad o pérdida de continuidad del esmalte **sin dentina visible**. La sonda roma puede caer ligeramente en la discontinuidad.

Profundidad aproximada: Esmalte hasta dentina externa

Manejo sugerido: Mínimamente invasivo: sellante o restauración preventiva, según actividad y radiografía.

Espacio reservado para fotografía clínica



CÓDIGO 4

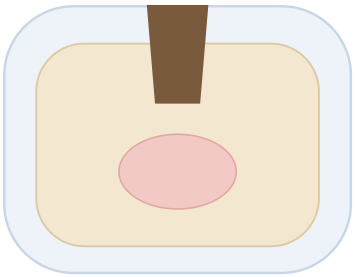
Sombra oscura subyacente de dentina

Sombra gris, azulada o marrón vista a través del esmalte, que puede estar íntegro o con ruptura localizada. Se aprecia mejor húmedo.

Profundidad aproximada: Dentina

Manejo sugerido: Valoración radiográfica: con lesión en tercio medio de dentina suele indicarse restauración conservadora.

Espacio reservado para fotografía clínica



CÓDIGO 5

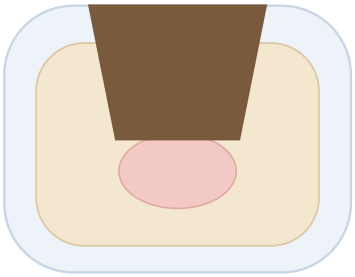
Cavidad evidente con dentina visible

Cavidad clara con dentina expuesta; afecta menos de la mitad de la superficie.

Profundidad aproximada: Dentina media a interna

Manejo sugerido: Operatorio: remoción selectiva de tejido cariado y restauración adhesiva.

Espacio reservado para fotografía clínica



CÓDIGO 6

Cavidad extensa con dentina visible

Cavidad profunda y amplia, con dentina claramente visible; afecta más de la mitad de la superficie. Puede comprometer la pulpa.

Profundidad aproximada: Dentina profunda, posible pulpa

Manejo sugerido: Operatorio: evaluación pulpar, remoción selectiva y restauración; valorar tratamiento de conductos.

Espacio reservado para fotografía clínica

Actividad de la lesión

El mismo código puede requerir tratamientos distintos según la lesión esté activa (progresando) o inactiva (detenida).

Característica	Lesión activa	Lesión inactiva
Aspecto del esmalte	Blanco o amarillento opaco, sin brillo	Blanco, marrón o negro, brillante
Textura con sonda roma	Rugosa	Lisa y dura
Localización	Zonas de acúmulo de placa: fisuras, cerca de la encía, bajo el punto de contacto	Alejada de zonas de acúmulo
Dentina (códigos 5–6)	Blanda o correosa al tacto	Brillante y dura
Encía vecina	Frecuentemente inflamada	Sana

De la clínica a la radiografía (ICCMS)

Código radiográfico	Extensión en la radiografía
RA1	Mitad externa del esmalte
RA2	Mitad interna del esmalte
RA3	Tercio externo de la dentina
RB4	Tercio medio de la dentina
RC5	Tercio interno de la dentina, clínicamente cavitada
RC6	Hasta la pulpa

Árbol de decisión simplificado

Estadio ICCMS	Códigos ICDAS	Lesión activa	Lesión inactiva
Inicial	1 y 2	Barniz de flúor, sellante en fisuras, higiene y dieta; control en 3–6 meses	Prevención de rutina
Moderado	3 y 4	Sellante, infiltración o restauración mínimamente invasiva según radiografía (RA3 vs RB4)	Monitoreo; sellar si hay retención de placa
Extenso	5 y 6	Remoción selectiva y restauración; evaluar pulpa	Restaurar si hay función o estética comprometida; si no, monitorear

Detalle que cambia el pronóstico
Registra el riesgo de caries del paciente (dieta, flúor, flujo salival, placa, historia de caries). Un código 2 activo en un paciente de alto riesgo necesita un plan preventivo intensivo aunque no se restaure.

Referencias

1. Ismail AI, Sohn W, Tellez M, et al. The International Caries Detection and Assessment System (ICDAS): an integrated system for measuring dental caries. Community Dent Oral Epidemiol. 2007;35(3):170–178.
2. Pitts NB, Ismail AI, Martignon S, et al. ICCMS™ Guide for Practitioners and Educators. ICDAS Foundation; 2014.
3. Nyvad B, Machiulskiene V, Baelum V. Reliability of a new caries diagnostic system differentiating between active and inactive caries lesions. Caries Res. 1999;33(4):252–260.

Material de apoyo educativo para miembros del Club OdonTeck. No sustituye el juicio clínico, la valoración individual del paciente ni las guías y normas vigentes. Verifica dosis e indicaciones con la ficha técnica de cada producto.